

ĐỀ CƯƠNG SK MT 2018

Câu 1. Mối liên quan giữa các yếu tố MT và SK con người.	2
Câu 2. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm MT, nâng cao SK:.....	3
Câu 3. Tác động của đất bị ô nhiễm do tác nhân sinh học theo đường người-đất- người tới SK bệnh tật con người.	4
Câu 5: Tác động của đất bị ô nhiễm do tác nhân sinh học theo đường động vật - đất-người tới SK bệnh tật của con người	8
Câu 6. Những nguy cơ cho SK do ô nhiễm nước từ tác nhân sinh học và các bệnh do ô nhiễm nước do tác nhân sinh học gây ra đối với SK con người.	10
Câu 8. Các hình thức cung cấp nước cho các vùng địa lý:	14
Câu 9. Trình bày nguồn, tác nhân gây ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí đến SK: (đọc kỹ nếu có rút gọn trong đề thi)	16
Câu 10. Các yếu tố nguy cơ cho SK trong MT đô thị.....	19
Câu 11. Các vấn đề SK của dân cư đô thị.....	20
Câu 12. Nguyên nhân, yếu tố nguy cơ các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị học đường.....	22
Câu 13. Ảnh hưởng SK và biện pháp dự phòng các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị học đường.	23
Câu 14. Các biện pháp xử lý chất thải của người.	24
Câu 15. Nhiễm trùng bệnh viện và các biện pháp dự phòng.	26
Câu 16. Tác hại của các chất gây ô nhiễm nhà ở với SK.....	27
Câu 17. Các bệnh tật liên quan đến lối sống: (Chỉ học phần béo phì).....	29
Câu 18. Nội dung, yêu cầu đánh giá tác động MT.....	30
Câu 19: Định nghĩa thảm họa MT, phân loại và 10 nhiệm vụ cấp bách của y tế tuyến tính khắc phục hậu quả lũ lụt:	32
Câu 20: Các biện pháp dự phòng trong và sau thảm họa:.....	34

Câu 1. Môi liên quan giữa các yếu tố MT và SK con người.

***MT** là bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có mối quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

***SK** là sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không phải chỉ là một tình trạng không bệnh tật hay tàn tật.

***SKMT** là các vấn đề SK của con người (bao gồm cả chất lượng cuộc sống) do các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, xã hội và các yếu tố tâm lý trong MT gây nên.

***Nguyên lý sinh thái học:** Con người cũng như mọi sinh vật đều sống dựa vào MT đặc trưng của mình, ngoài MT đó ra sinh vật không thể tồn tại được. Giữa sinh vật và MT có mối tương tác hữu cơ, biện chứng, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. MT ổn định thì sinh vật và con người sống ổn định và phát triển hưng thịnh. MT suy thoái, sinh vật và con người cũng bị suy giảm về chất lượng và số lượng. MT bị ô nhiễm, hủy hoại thì con người và sinh vật cũng bị chịu chung số phận.

*** Những yếu tố MT gây nguy hại cho sức khỏe :** 2 nhóm chính:

- Nhóm các yếu tố truyền thống:

- + Thiếu nguồn nước sạch
- + Vệ sinh MT kém
- + Nước thải, rác thải không được thu gom, xử lý
- + Ô nhiễm không khí trong nhà
- + Thực phẩm bị ô nhiễm do vi sinh vật
- + Lao động nặng nhọc trong điều kiện tồi tàn, lạc hậu, ô nhiễm
- + Các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán...

- Nhóm các yếu tố hiện đại:

- + Ô nhiễm không khí do khí thải công nghiệp, do giao thông, ô nhiễm tiếng ồn
- + Ô nhiễm đất, ô nhiễm các nguồn nước do nước thải, rác thải công nghiệp
- + Tai nạn giao thông, tai nạn do lao động sản xuất, do sinh hoạt
- + Ô nhiễm MT do các loại hoá chất công nghiệp, hoá chất trừ sâu dùng trong nông nghiệp.
- + Thực phẩm bị ô nhiễm do các hoá chất độc dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến
- + Tài nguyên cạn kiệt, nạn phá rừng, khai thác tài nguyên cạn kiệt, gây suy thoái MT, làm giảm đa dạng sinh học.
- + Gây thay đổi toàn cầu như mưa axit, lỗ thủng tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ trái đất, biến đổi khí hậu, gây các thảm họa thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt...
- + Lối sống không lành mạnh cũng đang là một yếu tố MT gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng, nhất là ở các đô thị hiện nay do ăn uống không hợp lý, uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, ăn nhiều thịt, mỡ, đồ ngọt, làm việc căng thẳng, ít vận động, hút thuốc lá, sử dụng ma túy, tình dục không an toàn.

*** Tác động của nguy cơ truyền thống** thường nhanh chóng nhanh chóng biểu hiện ở dạng bệnh tật, do vậy dễ được phát hiện và phòng tránh như khi dùng nguồn nước bẩn sẽ dễ gây tiêu chảy, gây các bệnh về da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục...

***Tác động của các nguy cơ hiện đại** thường biểu hiện từ từ, lặng lẽ, tiềm tàng, rất khó nhận biết được ngay và khi phát hiện ra thì đã có hậu quả nặng nề như nhiễm độc nghề nghiệp, ung thư, tăng đường huyết, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh...

Câu 2. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm MT, nâng cao SK:

Các biện pháp phòng chống ô nhiễm MT, nâng cao SK là tổng hợp của các giải pháp về kỹ thuật và hành chính nhằm bảo vệ MT không bị ô nhiễm, hoặc ô nhiễm trong tiêu chuẩn cho phép, để không gây tác hại cấp tính hay mạn tính đối với SK con người và các biện pháp bảo vệ người tiếp xúc, hạn chế phơi nhiễm với các tác nhân gây ô nhiễm MT và giải quyết các hậu quả trên SK của người tiếp xúc.

1. Các biện pháp đối với MT (đất, nước, không khí, thực phẩm, nhà ở, bệnh viện, trường học, nơi công cộng...)

- Đánh giá MT:

Theo dõi, lấy mẫu, phân tích xác định các tác nhân gây ô nhiễm MT, đánh giá mức độ ô nhiễm, xác định các nguồn gây ô nhiễm, đường truyền ô nhiễm.

Kết quả đánh giá MT là căn cứ áp dụng các giải pháp làm giảm tác nhân ô nhiễm ngay tại nguồn thải và ngoài MT.

- Thực thi các chính sách

Thực thi các chính sách, chiến lược, các giải pháp hành chính, pháp luật về bảo vệ MT tại tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực trong quá trình phát triển KTXH.

2. Các biện pháp đối với người tiếp xúc (người lao động trong các ngành nghề, các cộng đồng dân cư bị ô nhiễm)

- Đánh giá tiếp xúc với ô nhiễm MT của người dân:

+ Phân tích, tính toán được mức độ ô nhiễm, cần ước tính ra liều tiếp xúc trung bình, liều tiếp xúc trung bình theo thời gian, liều tiếp xúc cao nhất.

Đối chiếu liều tiếp xúc với các tiêu chuẩn cho phép để đưa ra nhận định về những hậu quả của MT trên SK.

+ Đối với các trường hợp không thể đo lường được mức độ tiếp xúc (định lượng) mà chỉ ước lượng được nguy cơ (định tính) bằng cách xác định nguy cơ là số người đã từng tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

+ Mức độ ô nhiễm mà cộng đồng phải tiếp xúc càng cao, thời gian tiếp xúc càng dài thì nguy cơ càng cao.

- Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm MT lên SK :

+ Thông thường ảnh hưởng của MT lên SK được xác định thông qua các chỉ số mắc bệnh, tử vong của một số bệnh đặc trưng hoặc một số bệnh không đặc trưng.

+ Có các yếu tố MT khó xác định tác hại trên SK do tính đặc hiệu thấp.

Vì vậy, đánh giá ảnh hưởng của MT lên SK phải dựa vào tính phổ biến, vào quy luật của số đông: dựa vào các số liệu thống kê về tình hình mắc bệnh, tử vong qua khám định kỳ, khám sàng lọc, điều tra dịch tễ học, phỏng vấn về các vấn đề SK của từng nhóm đối tượng...

+ Ảnh hưởng của MT lên SK thường biểu hiện với hiện tượng tăng băng nổi: chỉ có một vài trường hợp tử vong (phần nổi của tăng băng), còn phần lớn số người đang bị bệnh ở thể lâm sàng hoặc tiền lâm sàng chưa được phát hiện.

- Khi xác định được những tác động của MT lên SK, cần xác định mối quan hệ nhân quả của tương tác này, từ đó đưa ra các biện pháp ưu tiên làm giảm ô nhiễm MT, bảo vệ và nâng cao SK.

Câu 3. Tác động của đất bị ô nhiễm do tác nhân sinh học theo đường người-đất-người tới SK bệnh tật con người.

1.Định nghĩa: Ô nhiễm đất là những biến đổi tính chất, thành phần của đất, gây nên tác hại tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái không chỉ hiện tại mà cả tương lai lâu dài.

Những tác nhân sinh học có thể làm ô nhiễm đất và gây ra bệnh ở người được chia làm 3 nhóm:

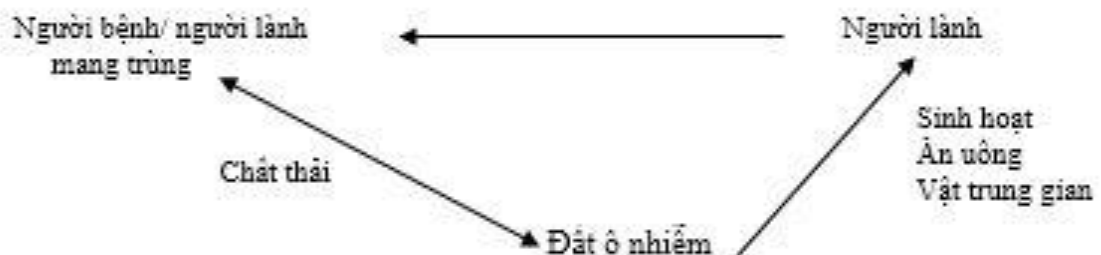
Tác nhân truyền bệnh Người - Đất - Người

Tác nhân truyền bệnh Động vật- Đất – Người

Tác nhân truyền bệnh Đất- Người

2.Tác nhân truyền bệnh Người- Đất- Người

a.Cơ chế lan truyền:



- **Nguồn truyền nhiễm** là người bệnh, người lành mang trùng.

- **Đường truyền nhiễm** là do đất bị ô nhiễm lây sang người. Các tác nhân gây bệnh đường ruột được đào thải từ người bệnh, người lành mang trùng trực tiếp vào đất mà không được xử lý hoặc xử lý không triệt để.

-**Khối cảm thụ** là người lành.

Con người nhiễm các tác nhân khi sinh hoạt(trẻ em, chế biến thực phẩm, bàn tay), trong lao động sản xuất(mắc giun móc, giun mỏ) hoặc do các vật trung gian truyền bệnh mang vào thức ăn(ruồi...)

b.Đặc điểm chung:

-Đa số các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: Tả, lỵ, thương hàn, giun đũa, giun xoắn, VG A...

-Các tác nhân có khả năng tồn tại khá bền vững ở MT đất.

c.Đặc điểm dịch tễ học:

-Gặp ở mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ em và người già.

-Thường gây dịch, liên quan đến mùa xuân hè.

-Gặp ở cộng đồng trình độ văn hóa thấp, nghèo đói, tập quán lạc hậu, điều kiện vệ sinh kém

- Kiến thức hạn chế và hành vi vệ sinh chưa đúng.

d. Các tác nhân cụ thể:

-Trực khuẩn lỵ: Trực khuẩn lỵ chết tương đối nhanh trong phân tươi, nhưng sau khi tẩy uế phân thì chúng có thể tồn tại lâu nhờ có chất hữu cơ trong đất. Nó thường bị các tia bức xạ mặt trời tiêu diệt. Người bị nhiễm khuẩn là do ăn phải rau quả bị đất làm nhiễm bẩn hay tiếp xúc với phân tươi.

-Trực khuẩn thương hàn và phó thương hàn: Đất trồng là MT không thuận lợi cho các loại vi khuẩn trên phát triển.. Tùy theo mức độ nhiễm bẩn và loại đất (nhiệt độ, độ ẩm, dự trữ chất hữu cơ, pH, khả năng lọc vi khuẩn đối kháng...) trực khuẩn thương hàn có thể tồn tại khá lâu (từ 2 đến 4 tuần hoặc hơn nữa) trong đất

-Phẩy khuẩn tả trong đất: Vibrio cholerae cổ điển, Vibrio Eltor. Phẩy khuẩn tả tồn tại ở trong đất không quá một tháng. Khả năng sinh tồn của nó chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Đất bị nhiễm bẩn bởi phân tươi, Các chất hữu cơ kéo dài thời gian tồn tại của phẩy khuẩn tả từ 5 - 7 tháng.

-Các loại ký sinh trùng (giun sán):

Ký sinh trùng được truyền qua đất hoặc trứng giun sán, ấu trùng của chúng sau thời gian ủ bệnh trong đất, trở thành tác nhân gây bệnh cho người. Giun đũa, giun xoắn Necator americanus và giun móc, tác nhân gây bệnh giun móc. Giun lươn ít truyền bệnh qua đất hơn. Những giai đoạn tự do của giun sán lan truyền qua đất nhiều nguy cơ.

Bệnh lỵ đường ruột: Entamoeba dysenteria có thể tồn tại ở trong đất nhất là đất bị ô nhiễm phân.

-Các virus đường ruột:

Trong đất người ta tìm thấy vi rút bại liệt ECHO và Cocksackie (chủng ECHO7 và ECHO9) gây viêm màng não và sốt phát ban, viêm cơ tim, viêm não trẻ sơ sinh.

Virút đường ruột chịu đựng bền vững các tác nhân lý - hoá và sống dai dẳng ở ngoại cảnh.

3.Biện pháp dự phòng:

-Quản lý và xử lý chất thải “ Ba diệt”

-Cung cấp nước sạch, cải thiện kinh tế.

-Nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh.

Câu 4: Tác động của đất bị ô nhiễm do tác nhân sinh học theo đường đất-người tới SK bệnh tật của con người

1. Định nghĩa: Ô nhiễm đất là những biến đổi tính chất, thành phần của đất, gây nên tác hại tới sức khoẻ con người và môi trường sinh thái không chỉ hiện tại mà cả tương lai lâu dài.

Những tác nhân sinh học có thể làm ô nhiễm đất và gây ra bệnh ở người được chia làm 3 nhóm:

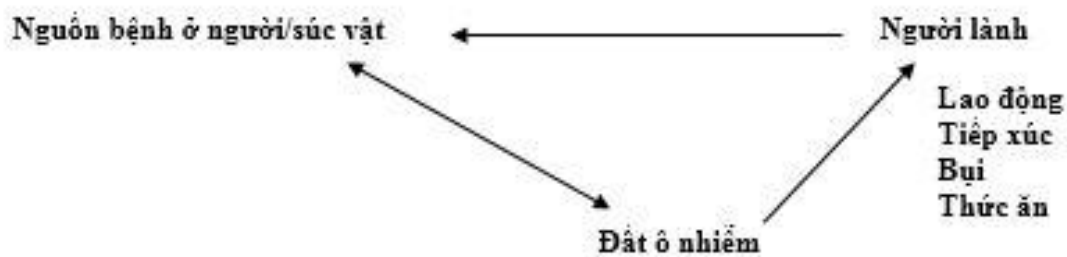
Tác nhân truyền bệnh Người - Đất - Người

Tác nhân truyền bệnh Động vật- Đất – Người

Tác nhân truyền bệnh Đất- Người

2. Tác nhân truyền bệnh đất -người:

a. Cơ chế lan truyền:



-**Nguồn truyền nhiễm** là người, súc vật bị bệnh

-**Đường truyền nhiễm:** Tác nhân gây bệnh tồn tại trong MT đất, lây nhiễm cho người khi tiếp xúc

-**Khởi cảm nhiễm** là người lành. Con người trong lao động, sinh hoạt, chế biến thức ăn tiếp xúc với đất bẩn chứa tác nhân gây bệnh có thể mắc các bệnh này

b. Đặc điểm chung:

-Tác nhân rất bền vững ở MT do tạo nha bào

-Nguồn ẩn, đất là nơi lưu giữ tác nhân

c. Đặc điểm dịch tễ học

-Gặp ở những người có tiếp xúc với mầm bệnh

-Dịch thường lẻ tẻ

-Cộng đồng thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt

d.Các tác nhân cụ thể:

-Các bệnh nấm: Hầu hết các bệnh nấm nặng ở da ăn sâu vào trong hay lan toàn thân đều được gây ra do nấm hoặc xạ khuẩn (Actinomicetes). Chúng phát triển bình thường như những vi khuẩn hoại sinh ở trong đất. Xâm nhập vào da qua vết thương. Những u nấm hay gặp trước hết ở những người đi chân đất hoặc đi giày dép, mặc quần áo không đủ bảo vệ da. Bệnh nấm *Coccidioides do nấm Coccidioides immitis*

gây ra thường được gặp ở những vùng khô hạn hay bán khô hạn.

-Uốn ván: Uốn ván là một bệnh nặng của người do độc tố của trực khuẩn *Nicolaire* gây ra. Chúng phát triển kỵ khí ở những vết thương nhiễm khuẩn. Bệnh thường gặp ở những người làm nông nghiệp, chủ yếu do những vết thương xây xát, bị nhiễm khuẩn tiếp xúc với đất bón, phân. Tác nhân nhiễm khuẩn *Clostridium tetani* do những súc vật bị nhiễm khuẩn đặc biệt là ngựa. Nguồn gây nhiễm tức thời có thể là đất, bụi hoặc những chất thải của súc vật và người. Vi khuẩn uốn ván gặp khá nhiều trong đất canh tác cũng như (đôi lúc) trong đất bỏ hoang. Càng lên cao (vùng núi) càng ít gặp vi khuẩn này. Đất bón phân chuồng chứa nhiều vi khuẩn này.

-Ngộ độc thịt: (do *Clostridium Botulium*): Bệnh ngộ độc thịt là một bệnh ngộ độc thường gây chết người do những độc tố của *Clostridium Botulium* gây ra. Nguồn mầm bệnh là đất hoặc từ ruột súc vật bị bệnh. Độc tố được tạo nên do sự phát triển kỵ khí của các nha bào trong thức ăn và gây ngộ độc tức thời.

Cl. botulium có nhiều ở đất canh tác, trồng trọt, kiềm, trung tính và ở một vài loại động vật trong đất

3.Biện pháp dự phòng

- Nâng cao nhận thức
- Quản lý, xử lý chất thải
- Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Bảo hộ lao động

Câu 5: Tác động của đất bị ô nhiễm do tác nhân sinh học theo đường động vật - đất-người tới SK bệnh tật của con người

1. Định nghĩa: Ô nhiễm đất là những biến đổi tính chất, thành phần của đất, gây nên tác hại tới sức khỏe con người và môi trường sinh thái không chỉ hiện tại mà cả tương lai lâu dài.

Những tác nhân sinh học có thể làm ô nhiễm đất và gây ra bệnh ở người được chia làm 3 nhóm:

Tác nhân truyền bệnh Người - Đất - Người

Tác nhân truyền bệnh Động vật- Đất – Người

Tác nhân truyền bệnh Đất- Người

2. Tác nhân truyền bệnh động vật- đất- người:

a. Cơ chế lan truyền:



-**Nguồn truyền bệnh** là động vật ốm, bệnh, bị chết.

-**Đường truyền nhiễm:** Tác nhân gây bệnh tồn tại trong động vật lây truyền trực tiếp qua người. Tác nhân gây bệnh đào thải ra MT và tồn tại trong đất do không được xử lý, chôn cất đúng quy tắc vệ sinh

-Khối cảm thụ:

+Người lành mắc bệnh khi tiếp xúc với động vật mắc bệnh hoặc do vật trung gian mang mầm bệnh đặc biệt là những người chăn nuôi, giết mổ động vật

+Người lành mắc bệnh khi tiếp xúc với đất bị ô nhiễm bởi tác nhân gây bệnh khi sinh hoạt, lao động, sản xuất như những người thăm dò địa chất, người đi du lịch sinh thái(ở nơi có các ổ dịch hoang dại)

+Vật nuôi mắc bệnh khi tiếp xúc với đất bẩn, điều kiện chuồng trại không vệ sinh

b. Đặc điểm chung:

-Các bệnh súc vật, vật nuôi

-Con người ngẫu nhiên rơi vào chu trình dịch súc vật

c. Đặc điểm dịch tễ học:

-Gặp ở mọi người tiếp xúc với súc vật: địa chất, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch sinh thái...

-Đôi khi có dịch lớn, thường lẻ tẻ, có đặc điểm dịch tự nhiên

-Cộng đồng hiểu biết hạn chế, thiếu TTB bảo hộ lao động.

d.Các tác nhân cụ thể: Trong số bệnh của súc vật truyền sang người, đất có thể giữ vai trò chủ yếu truyền tác nhân nhiễm khuẩn từ vật nuôi sang người.

-Bệnh xoắn khuẩn vàng da (bệnh do *Leptospira*): *Leptospira* gây bệnh đồng thời cho vật nuôi và cho người tất cả mọi nơi trên thế giới.

Chủ yếu vẫn là ở trâu bò, trong một số vùng, dê, cừu, ngựa cũng bị nhiễm khuẩn. Chuột cống, chuột chù, chuột đồng thường mang mầm bệnh.

Sự lan truyền xoắn khuẩn *Leptospira* liên quan rõ rệt với tiếp xúc với vật nuôi mắc bệnh, với nước hoặc bùn nhiễm xoắn khuẩn.

-Trực khuẩn than: Người mắc bệnh than ít gặp.

Trực khuẩn than đề kháng cao với những tác nhân hoá học và với những điều kiện bất thuận lợi của MT bao quanh.

Có thể sống hàng năm trong đất và trong những tổ chức của động vật như da, lông ngựa, lông cừu.

Khi mầm bệnh lưu trú trong vật nuôi ở một vùng nào đó, ổ gây bệnh sẽ được phát sinh đối với các động vật do khả năng thường trú của mầm bệnh trong đất.

-Bệnh sốt phát ban: *Rickettsia*

-Bệnh sốt Q: Bệnh sốt Q được gây ra bởi *Coxiella Burnetii*.

-*Rickettsia* có thể có mặt trong đất và bụi, ở nơi mà chúng có thể sinh tồn trong những thời kỳ dài nhờ ở sức đề kháng mạnh mẽ của chúng với điều kiện khô hanh.

Nguồn bệnh: Cừu, dê, mèo

-Bệnh viêm da do giun/ ấu trùng lạc chỗ. Bệnh viêm da này thường gặp ở những nơi có nhiều mèo, chó nhiễm *Ankylostoma braziliense*.

Người bị nhiễm bệnh do sự thâm nhập vào da của những ấu trùng giun móc và/hoặc nhiễm giun đũa chủng động vật

Nhiễm bệnh này thường ở những người phải tx với chất phóng uế của vật nuôi thải ra đặc biệt trẻ em.

3.Biện pháp dự phòng:

-Kiểm soát, dự báo dịch thú y

-Vệ sinh MT, chuồng trại

-Bảo hộ lao động khi tiếp xúc vật nuôi

-Nâng cao nhận thức cộng đồng, vệ sinh phòng bệnh

Câu 6. Những nguy cơ cho SK do ô nhiễm nước từ tác nhân sinh học và các bệnh do ô nhiễm nước do tác nhân sinh học gây ra đối với SK con người.

1. Định nghĩa: Ô nhiễm nước là sự biến đổi các thành phần của nước khác biệt với trạng thái ban đầu làm cho chúng trở thành độc hại, không có lợi cho SK.

2. Tác hại của ô nhiễm nước tới SK: Có hai dạng tác hại:

- Nguy cơ do các tác nhân sinh học có khả năng truyền bệnh cho con người qua nước uống, qua thức ăn bị nước làm ô nhiễm và qua tiếp xúc với nước hoặc do các vật chủ trung gian và côn trùng gây bệnh

- Nguy cơ do các chất hoá học, phóng xạ có trong nước: Nguy hại đến SK con người do uống nước trực tiếp, do ăn các loại thực phẩm bị ô nhiễm qua hệ sinh thái do các chất hay các chất phân hủy của chúng hoặc do sử dụng nước trong vệ sinh cá nhân, trong lao động phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, trong nghỉ ngơi hoặc do sống gần các nguồn nước

3. Những tác hại do tác nhân sinh học:

Nguy cơ vi sinh vật xếp thành 4 loại: vi khuẩn gây bệnh, virus, ký sinh trùng và các tác nhân sinh học khác

a. Vi khuẩn gây bệnh qua đường tiêu hóa:

Các loại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể con người trực tiếp qua uống nước hoặc gián tiếp qua các loại thực phẩm và nước dùng để chế biến thực phẩm

Các vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong nước có thể gây các bệnh như:

***Bệnh tả:** là bệnh truyền nhiễm cấp tính do phẩy khuẩn tả gây ra. Ở Việt Nam chủ yếu do type sinh học Eltor lây truyền bằng đường tiêu hóa. Biểu hiện: ỉa lỏng, nôn nhiều, nhanh chóng mất nước điện giải, trụy tim mạch, tử vong nếu không điều trị kịp thời. Đây là dịch bệnh điển hình của các bệnh lây đường tiêu hóa, lan rộng nhanh

***Bệnh thương hàn:**

Là bệnh nhiễm trùng toàn thân do salmonella typhi, biểu hiện sốt kéo dài, gây nhiều biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, thủng ruột

***Bệnh lỵ trực khuẩn:**

Là một viêm đại tràng cấp tính gây bởi vi khuẩn Shigella, theo cơ chế phân – miệng hoặc từ người sang người hoặc từ bàn tay nhiễm khuẩn, lây gián tiếp chủ yếu qua nước uống, thức ăn. Ở nước ta nước là trung gian truyền lỵ hàng đầu.

*Các vi khuẩn tồn tại trong nước cũng gây ra các bệnh dễ lan truyền nhanh như: tiêu chảy trẻ em do chủng E. Coli gây bệnh, các bệnh đường ruột khác như phó thương hàn

b. Virus:

***Virus nhiễm qua đường tiêu hóa:**

-Viêm dạ dày ruột nguồn gốc virus: thường kéo dài 24-72 giờ kèm buồn nôn, nôn, ỉa chảy xảy ra ở mọi lứa tuổi. Trầm trọng nhất là trẻ nhỏ và người già.

-Viêm gan A: Virus nhiễm qua đường tiêu hóa rồi thải qua phân và nhiễm vào nước. Viêm gan A xảy ra theo dịch địa phương và bộc phát thành vụ dịch quan trọng. Virus VGA có tính đề kháng cao ở MT ngoài

-Bệnh bại liệt: Virus nhiễm vào người qua đường ăn uống và thải qua phân. Biểu hiện: gây liệt mềm, không hồi phục sau khi chữa khỏi

***Virus nhiễm qua đường niêm mạc:**

Đó là Adenovirus đóng vai trò trong bệnh viêm kết mạc. Gặp ở bể bơi công cộng

c. Ký sinh trùng:

*** KST gây bệnh nhiễm qua đường tiêu hóa:**

-Bệnh lỵ amip: gây ra do Entamoeba histolytica. Tổn thương bệnh lý xảy ra ở đại tràng hoặc ngoài đại tràng

-Bệnh do Giardia: gây rối loạn đường ruột nghiêm trọng

-KST Cyclospora có trong nước gây tiêu chảy kéo dài

***Bệnh do KST thâm nhập từ nước qua da và niêm mạc:** Khi tiếp xúc với nước, các KST có thể thâm nhập qua da hoặc niêm mạc như các loại sán máng gây nên bệnh sán máng

d. Những nguy cơ do tác nhân sinh học truyền qua nước bằng những đường khác:

***Bệnh nhiễm sán do vật chủ trung gian sống trong nước:**

-Sán lá gan, sán lá ruột, sán máng. Cách không chế: không ăn sống thủy sản trồng trong nước, điều trị triệt để người mắc

***Các bệnh do côn trùng liên quan đến nước:**

Muỗi gây bệnh sốt rét gồm 4 loại Anophen, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết Aedes Aegypti, muỗi gây bệnh gian chỉ

Phòng chống các bệnh trên bằng các tiêu diệt nơi muỗi đẻ trứng, diệt ấu trùng muỗi, diệt muỗi bằng phun thuốc, đèn bắt, chống muỗi đốt bằng nằm màn, màn tẩm hóa chất

e. Các bệnh do không có nước hoặc nước không sạch: cách lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành. Các bệnh thường gặp là đau mắt hột, các bệnh da: ghẻ, nấm, chàm...

Cách phòng chống:

Xử lý nước thải đúng quy định

Sử dụng nước hợp vệ sinh

Thực hiện ăn chín uống sôi

Cung cấp nước sạch, vệ sinh sạch sẽ

Câu 7: Những nguy cơ cho SK do ô nhiễm nước từ tác nhân hóa học và các bệnh do ô nhiễm nước do tác nhân hóa học gây ra đối với SK con người

1. Định nghĩa: Ô nhiễm nước là sự biến đổi các thành phần của nước khác biệt với trạng thái ban đầu làm cho chúng trở thành độc hại, không có lợi cho SK.

2. Tác hại của ô nhiễm nước tới SK: Có hai dạng tác hại:

- Nguy cơ do các tác nhân sinh học có khả năng truyền bệnh cho con người qua nước uống, qua thức ăn bị nước làm ô nhiễm và qua tiếp xúc với nước hoặc do các vật chủ trung gian và côn trùng gây bệnh
- Nguy cơ do các chất hoá học, phóng xạ có trong nước: Nguy hại đến SK con người do uống nước trực tiếp, do ăn các loại thực phẩm bị ô nhiễm qua hệ sinh thái do các chất hay các chất phân hủy của chúng hoặc do sử dụng nước trong vệ sinh cá nhân, trong lao động phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, trong nghỉ ngơi hoặc do sống gần các nguồn nước

3. Nguy cơ do ô nhiễm nước, các bệnh do tác hại hóa học ô nhiễm nước gây ra:

***Các tác nhân hóa học gây nguy hại cho SK con người khi sự có mặt của chúng vượt quá nồng độ cho phép trong nước**

***Đường xâm nhập:**

- Trực tiếp: qua đường ăn uống, vệ sinh cá nhân hoặc qua việc sử dụng nước để nghỉ ngơi giải trí
- Gián tiếp: Qua việc phá hủy MT và tích lũy các chất gây ô nhiễm nước vào cơ thể khi con người sử dụng thực phẩm

***Nguy cơ hóa học, phóng xạ xếp thành 3 loại:** Các chất vô cơ, các chất hữu cơ, các chất phóng xạ

***Bệnh do các chất vô cơ:**

-Nitrat:

+Nguy hại cho SK khi vi khuẩn trong hệ thống tiêu hóa chuyển NO_3^- thành NO_2^- :

Gây bệnh Methemoglobin hay hội chứng xanh tím

+Nguy cơ gây ung thư tiềm tàng: do hình thành nitrosamin là một chất có khả năng gây ung thư

-Fluoride:

- +Tích lũy trong xương răng
- +Làm xương giòn, rạn nứt xương
- +Fluorosis làm xốp men răng, răng có nhiều lỗ thủng, hoen ố răng
- +Fluoride có thể tương tác với nhôm gây bệnh Alzheimer

-Asen:sự phơi nhiễm lâu dài asen qua nước uống gây ra:

- +Ung thư da, phổi, bàng quang, có thể ung thư gan, thận
- +Thay đổi sắc tố da, chai cứng da
- +Chưa rõ ràng: Bệnh tim mạch, tiểu đường, ảnh hưởng sinh sản
- +Bệnh máu ngoại vi: Bệnh đen chân dẫn đến hoại thư

-Chì:

Chì trong cơ thể gây phá hủy nghiêm trọng đến não, thận, hệ thống thần kinh và tế bào hồng cầu. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với chì, hậu quả là gây kìm hãm phát triển trí tuệ và thể lực của trẻ

-Đồng: là nguyên tố vi lượng thiết yếu của cơ thể nhưng cần với lượng nhỏ. Thừa Cu sẽ dẫn tới cơn đau dạ dày, ruột, buồn nôn, ỉa chảy, đặc biệt người có rối loạn gen

***Bệnh do các chất hữu cơ:**

-Hydrocacbua thơm đa vòng: Benzen, hợp chất nitro... có khả năng gây ung thư, làm tăng sinh khối u của người và động vật

-Các thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt côn trùng: Nhiều thuốc trừ sâu diệt cỏ phân hủy chậm và tích tụ lại trong MT qua chuỗi thức ăn theo nước, thực phẩm và cơ thể. Một số chất gây quái thai, dị dạng

***Bệnh do các chất phóng xạ:** các chất phóng xạ thâm nhập vào cơ thể con người qua nước uống và thực phẩm nhiễm xạ. Tùy theo mức độ ô nhiễm nặng nhẹ có thể làm chết vi sinh vật và người và làm thay đổi cấu trúc tế bào gây ra các bệnh di truyền, bệnh máu, ung thư

Câu 8. Các hình thức cung cấp nước cho các vùng địa lý:

Các hình thức cung cấp nước cho vùng đồng bằng, ven biển, ngoài các hình thức cung cấp nước tập trung thì có một vài hình thức cung cấp nước phân tán, nhỏ lẻ như công trình thu nước mưa, giếng thu nước ngầm nông, giếng đào nông, giếng hào lọc.

Các công trình nhỏ lẻ:

1. Công trình thu nước mưa:

Nước mưa được sử dụng thích hợp cho các vùng:

- Miền núi cao không có mạch nước ngầm, nước mặt
- Vùng ven biển, hải đảo không có nguồn nước ngọt.
- Các vùng đồng bằng nơi nguồn nước ngầm nông chất lượng kém.

Cấu tạo: Gồm bể chứa và hệ thống hứng, dẫn nước mưa. Vật liệu xây dựng bể phổ biến nhất là gạch, có thể xây bằng đá hoặc đổ bê tông. Bể chứa có thể được xây ngầm, xây nổi hoặc nửa nổi, nửa chìm. Khi bể có dung tích lớn nên chia làm nhiều ngăn để tiện cho việc sử dụng và thay rửa.

Yêu cầu vệ sinh:

- Thường xuyên quét sạch rác, bụi có trên mái hứng và máng thu nước.
- Loại bỏ nước mưa ban đầu đến khi mái hứng và máng thu đã được rửa sạch.
- Các dụng cụ chứa nước phải có nắp đậy kín, có vòi để dễ lấy nước, định kỳ thay tất làm vệ sinh và nên nuôi cá vàng để diệt bọ gậy.

2. Giếng thu nước ngầm nông.

Vùng: Áp dụng cho các vùng nguồn nước ngầm nông có chất lượng tốt.

Cấu tạo: Giếng khơi thường có đường kính từ 0,8m đến vài mét, thành giếng có thể xây bằng gạch, đá, đổ bê tông cốt thép.

Chiều sâu giếng phụ thuộc vào độ sâu tầng chứa nước. Khi tầng chứa nước mỏng, các giếng được đào xuyên tới lớp đất không thấm nước, nước chảy vào giếng sẽ được lấy vào từ thành giếng. Lấy nước từ đáy thì thành giếng phải chắc chắn, đáy giếng là vật liệu đỡ gồm cát, sỏi, đá gọi là lớp lọc ngược dày 0,3 - 0,6m.

Yêu cầu vệ sinh:

- Thành giếng cao hơn mặt đất 0,8m.
- Cổ giếng phải chèn lớp đất sét dày 0,5m và sâu 1,2m
- Sân giếng xây bằng gạch, bê tông, có rãnh thoát nước
- Có nắp đậy giếng
- Nếu dùng gàu múc nước, phải có giá đỡ gàu
- Giếng phải xa nguồn ô nhiễm nhất là hố xí, chuồng gia súc với khoảng cách vệ sinh tối thiểu 10m.

- Khi nước trong các giếng khơi không bảo đảm yêu cầu về chất lượng, cần phải xây dựng các công trình xử lý: làm trong hoặc khử sắt... phổ biến nhất là bể lọc chậm.

3. Giếng đào nông: (giếng khơi sâu 3-4m)

Vùng: Thích hợp cho vùng ven biển và hải đảo.

Cấu tạo: Giếng sâu 3-4m. Thành giếng, đáy giếng có lớp cát lọc dày 40cm.

Yêu cầu vệ sinh:

- Tận dụng nước mưa thấm qua cát hoặc đất pha cát thành lớp nước nổi trên nước mặn.

- Giếng không sâu quá 3m, đường kính lớn

- Thành giếng trát kín bằng xi măng, có chu vi bảo vệ giếng và rãnh thoát nước

4. Giếng hào lọc:

*Áp dụng cho các vùng:

Tại các vùng nguồn nước ngầm nông chất lượng kém

Đào sâu vẫn không gặp mạch nước

Vùng ven biển gặp mạch nước mặn

=>đào giếng hào lọc để lấy nước lọc từ hồ, ao, mương máng dẫn nước.

Cấu tạo của giếng hào lọc gồm 2 phần: Giếng và hào lọc.

Giếng cấu tạo như giếng khơi

Hào lọc có đường kính bằng 1/2 đường kính của giếng, cách ao 2 m, sâu hơn hoặc bằng đáy ao, dốc thoải thoải đến giếng. Có 2 loại hào lọc: Hào lọc đáy hở và hào lọc đáy kín.

-Giếng hào lọc đáy hở: Đào một hào từ giếng cách ao khoảng 2m, dốc thoải thoải đến giếng, cách ao một đoạn đất mỏng. Trong hào đổ cát vàng hay cát đen, dày 0,7-0,8 m được lèn nện kỹ, sau đó đổ đất lên trên. Vách giếng được miết xi măng nhưng giữa 2 khẩu không trát kín để cho nước thấm vào giếng.

Nước qua giếng trong, chất hữu cơ giảm.

-Hào lọc đáy kín dùng ở vùng ven biển. Hào được xây bằng gạch, được trát kín ở đáy và vách để tránh sự xâm nhập của nước mặn, nước bẩn. Khác với hào đất, hào gạch ăn thông với giếng. Vách giếng và hào lọc có đặt thêm vỉ tre đan và sát thành giếng đổ một lớp sỏi nhỏ để giữ cát không tràn vào giếng. Có thể làm nắp đáy bằng bê tông để thay cát sỏi khi cần thiết. Nước ao, hồ, mương qua hào lọc cát, sỏi sẽ có chất lượng tốt hơn: nước trong, hàm lượng các chất hữu cơ giảm.

Yêu cầu vệ sinh: cần chọn ao hồ sạch, giữ gìn vệ sinh ngoại cảnh tốt và thay lớp lọc khi cần thiết. Giếng hào lọc có yêu cầu vệ sinh như giếng khơi xây khẩu.

Câu 9. Trình bày nguồn, tác nhân gây ô nhiễm không khí và tác động của ô nhiễm không khí đến SK: (đọc kỹ nếu có rút gọn trong đề thi)

1.Định nghĩa: Ô nhiễm không khí là sự biến đổi các thành phần trong không khí hoặc sự xuất hiện của một vật thể lạ trong thành phần không khí và tác động có hại với đời sống nói chung và con người nói riêng.

2.Nguồn gây ô nhiễm không khí:

Có hai nguồn chính:

a. Nguồn ô nhiễm thiên nhiên:

- Do các hiện tượng thiên nhiên gây ra : sa mạc hoá, thoái hoá đất trồng trọt, cháy rừng, bão cát...
- Núi lửa : nham thạch, hơi khí từ lòng đất
- Nước bắn bốc hơi, bụi muối biển
- Sự huỷ hoại, thối rữa của thực vật và động vật

b. Nguồn ô nhiễm nhân tạo:

***Do sản xuất công nghiệp:**

Từ tất cả các ngành công nghiệp : gang thép, luyện kim, xi măng, hóa chất, giấy, đồ nhựa, lọc dầu,...

- Nguồn:

- Khói của các nhà máy sản xuất công nghiệp thải chất khí độc hại
- Bốc hơi, rò rỉ, thất thoát khí độc hại trên dây chuyền, đường ống...trong sản xuất

- Đặc điểm

- Nồng độ chất độc hại rất cao

Tập trung trong một khoảng không gian nhỏ

***Do giao thông vận tải:**

-. Nguồn:

- Do hoạt động của các loại động cơ
- Sản sinh ra các loại khí độc hại : oxyt cacbon CO, hydro CH, nitơ oxyt NO,..

-. Đặc điểm :

- Nguồn ô nhiễm thấp
- Phân tán trong một không gian lớn

***Do sinh hoạt của con người:**

-Nguồn:

- Do bếp đun và lò sưởi
- Đốt các loại nhiên liệu : than, củi, dầu hoả và khí đốt.
- Cỏ làng nghề

- Đặc điểm :

- Nguồn ô nhiễm nhỏ
- Gây ô nhiễm cục bộ : gia đình, khu tập thể, khu dân cư

3.Tác nhân gây ô nhiễm không khí: bao gồm 3 loại:

- Các tác nhân sinh học : vi khuẩn, virus, nấm,..
- Các tác nhân hóa học : các loại khí độc, berilli, mangan, hợp chất fluor, thuốc trừ sâu,..
- Các tác nhân lý học : bụi, chất phóng xạ, sóng từ, tiếng ồn, chiếu sáng, nhiệt...

Cụ thể:

a.các tác nhân sinh học:

- Các loại vi khuẩn gây bệnh: Tụ cầu vàng, liên cầu tan máu, trực khuẩn lao, trực khuẩn than, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn dịch hạch, phế cầu, tồn tại trong không khí từ 3 ngày đến 6 tháng.
- Các loại vi rút gây bệnh (siêu vi khuẩn). Vi rút cúm, vi rút sởi, vi rút quai bị, vi rút đậu mùa...
- Các loại bào tử nấm: Nấm *Actinomyces minutissimus* gây hăm bẹn, bìu..., nấm *Trichophyton* gây bệnh ở tóc, da (bệnh vẩy rồng, Eczema), nấm *Candida* gây bệnh ở niêm mạc, gây dị ứng.
- Các loại dị nguyên gây dị ứng. Phấn hoa, bụi nhà, lông súc vật...

b.Các tác nhân hóa học:

- Đó là các loại hơi khí độc sau:
- Các hợp chất của lưu huỳnh: SO_2 , SO_3 , H_2SO_4 , H_2S ...
- Các hợp chất của nitơ: NO , NO_2 , N_2O , NH_3 ...
- Các hợp chất của các bon: CO , CO_2 , Aldehyt, Axetôn, Benzen, formaldehyd, các axit, các khí có từ 1 đến 5 các bon như Mêtan (CH_4).
- Các hợp chất của halogen: HCl , HF , Cl_2 ...
- Các hydrocacbon thơm đa vòng: 3 - 4 benzoapyren, Ba polycyclic aromatic hydrocacbon (PAH)...
- Các hoá chất trừ sâu diệt cỏ: DDT, Photpho hữu cơ, lân hữu cơ...

c.Các tác nhân lý học:

- Các loại bụi: Bụi kim loại, bụi khoáng sản (than, đá, quặng...), bụi gỗ, bụi bông, bụi có chứa silic, chứa amiăng.
- Các loại bức xạ ion hoá (tia phóng xạ), các bức xạ hạt (α , β , neutron và bức xạ điện từ (tia x, γ))
- Tia cực tím (tia tử ngoại): Từ mặt trời, tăng lên do tầng ozon, tia laser.
- Sóng điện từ : trạm phát sóng phát thanh, truyền hình, viễn thông, ra đa, các máy móc điện tử tivi, điện thoại di động, các máy dùng điện máy, phát điện, dòng dẫn điện...
- Tiếng ồn, rung chuyển
- Áp suất không khí: Thay đổi áp suất không khí đột ngột
- Nhiệt độ, độ ẩm của không khí quá cao hoặc quá thấp

4.Tác động của ô nhiễm không khí đến SK :

Tác động cấp tính:

Tùy theo mức độ và thời gian tiếp xúc với tác nhân gây ô nhiễm:

- Kích thích mắt, da, niêm mạc: bụi hô hấp, viêm da, hơi khí độc...
- Nhiễm độc: bụi chì, benzen, hơi khí độc gây ngạt: CO , Metan...
- Tử vong: do ngộ độc cấp các hoá chất trừ sâu diệt cỏ Clo hữu cơ, lân hữu cơ...

Thảm họa tại thành phố Luân đôn: thảm họa khói mù, khói từ các lò sưởi, nhà máy thành phố làm thành khói mù dày đặc màu đen khiến 12000 người chết.

Tác động mạn tính:

- Viêm đường hô hấp: Hen, viêm phế quản mạn, lao, cúm, sởi...
- Ung thư phổi: Amiang...
- Tổn thương hệ thần kinh trung ương: Nhiễm độc mạn chì, thủy ngân
- Mệt mỏi, buồn phiền cáu gắt: Sóng điện từ, nhiệt độ và độ ẩm không khí cao...
- Tác hại lên giác quan: Viêm mũi họng mạn, điếc nghề nghiệp...
- Dị ứng da, viêm mạc: Viêm da do nấm: hắc bào, vẩy nến, dị ứng da và viêm mạc
- Giảm khả năng vận chuyển oxi: Nhiễm mạn khí CO,...
- Giảm hồng cầu máu: Bệnh lên cao

Liên hệ: các nhà máy xi măng HP, HD là nguồn gây ô nhiễm, bụi lơ lửng vùng dân cư quanh nhà máy xi măng cao hơn 3-8 lần TCCP, dân sống xung quanh có tỷ lệ nhiễm các bệnh hô hấp, dị ứng cao hơn so với vùng không ô nhiễm. Công nhân trong các nhà máy xi măng thì tiếp xúc với nồng độ bụi cao, không có đồ bảo hộ đạt tiêu chuẩn có khả năng cao gây ra các bệnh phế quản mạn tính, bệnh bụi phổi nghề nghiệp, ung thư phổi...

5..Biện pháp phòng chống: Căn cứ vào nguồn gây ô nhiễm

- **Do công nghiệp**
 - Quy hoạch đô thị và bố trí khu công nghiệp
 - Sử dụng các biện pháp công nghệ
 - Sử dụng các biện pháp làm sạch khí thải
- **Do giao thông vận tải**
 - Cải tạo và nâng cấp hệ thống giao thông
 - Phát triển hệ thống giao thông công cộng
 - Sử dụng xăng sinh học thay thế xăng hóa thạch
 - Cấm nhập khẩu xe cũ, xe không đạt tiêu chuẩn MT
 - Xây dựng trạm kiểm định chất lượng MT đối với các loại xe
- **Do sinh hoạt**
 - Sử dụng bếp ga, bếp điện
 - Hạn chế sử dụng bếp than, bếp dầu hỏa
 - Sử lý rác thải sinh hoạt
- **Quản lý và kiểm soát MT**
 - Xây dựng và thực hiện các luật về bảo vệ MT
 - Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm
 - Xây dựng hệ thống kiểm tra tự động
- **Trồng cây xanh**
- **Biện pháp kinh tế**
- **Giáo dục SK và nâng cao ý thức cộng đồng**
- **Giải pháp tổng thể/toàn cầu:** cắt giảm khí nhà kính, đánh thuế phát thải khí ô nhiễm, kí kết các Nghị định thư...

Câu 10. Các yếu tố nguy cơ cho SK trong MT đô thị.

1. Định nghĩa: Đô thị hóa

- Là biến thành đô thị, biến quần cư nông thôn thành quần cư đô thị
- Là quá trình tập trung nhân lực, vật lực trong một khoảng không gian nhất định để phát triển kinh tế xã hội, mang lại cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Là quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên MT vào mục đích phát triển và thải vào MT chất thải gây ô nhiễm MT.

*Các yếu tố nguy cơ cho SK MT đô thị:

-Do kinh tế: Thu nhập thấp, thiếu ăn...

-Do bản thân con người gây ra: ô nhiễm MT, giao thông, nhà ở quá chật chội, stress...

--Do xã hội không ổn định, mất an ninh trật tự, ma túy, thất học, lao động trước tuổi...

2. Các yếu tố nguy cơ cho SK trong MT đô thị

a. Yếu tố nguy cơ do phát triển kinh tế

- Các hoạt động phát triển kinh tế
- Phát triển công nghiệp, khai thác tài nguyên gây cạn kiệt, gây ô nhiễm MT đất, nước, không khí.
- Chính sách phân phối tiền tệ, giá cả dịch vụ đô thị không phù hợp dẫn đến nhiều dân nghèo không được quan tâm
- Khai thác bừa bãi tài nguyên và công nghiệp hóa không có quy hoạch tạo ra ô nhiễm MT, việc làm khó khăn, phúc lợi công cộng giảm
- Tỷ lệ phát triển kinh tế vượt quá khả năng do tăng dân số tự nhiên và di dân
- Tập trung dân cư
- Thiếu nhà ở, ở chật chội: tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, mạn tính và các tai nạn, các bệnh tâm thần
- Thiếu nước sạch
- Tắc nghẽn giao thông
- Thiếu bệnh viện, trường học, nơi vui chơi giải trí
- Thiếu khu vực có cây xanh, mặt nước MT trong sạch để nghỉ dưỡng
- Không thu gom xử lý được chất thải
- Nước thải, khí thải, rác thải gây ô nhiễm MT

b. Yếu tố nguy cơ do phát triển xã hội

- Phân hóa giàu nghèo, gây ra lớp người nghèo đô thị
- Họ phải lao động trong điều kiện MT ô nhiễm, thu nhập thấp
- Không được công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ xã hội: nhà ở, học tập, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí.
- Tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân: phụ thuộc vào nguồn cung cấp thực phẩm không an toàn, nguồn nước không sạch.
- Tập trung dân cư dễ làm phát sinh các thảm họa cháy nổ
- Nhu cầu công ăn việc làm gây căng thẳng xã hội
- Các tệ nạn (hút thuốc, uống rượu, ma túy, mại dâm), tai nạn, bạo lực...

Câu 11. Các vấn đề SK của dân cư đô thị.

1. Định nghĩa:

- Là biến thành đô thị, biến quần cư nông thôn thành quần cư đô thị
- Là quá trình tập trung nhân lực, vật lực trong một khoảng không gian nhất định để phát triển kinh tế xã hội, mang lại cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Là quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên MT vào mục đích phát triển và thải vào MT chất thải gây ô nhiễm MT

2. Các vấn đề SK dân cư đô thị:

- Các bệnh truyền nhiễm
- Các bệnh không truyền nhiễm và chấn thương
- Các vấn đề về SK tâm thần
- Các vấn đề SK đối với nhóm người đặc biệt

2.1. Các bệnh truyền nhiễm

Các bệnh truyền nhiễm thường tăng lên do:

- Tiêm chủng không đầy đủ
- Tại nơi ở MT bị ô nhiễm(đặc biệt do phân người, phân gia súc,rác thải chứa mầm bệnh...) phát triển các vector truyền bệnh(ruồi, muỗi...)
- Ở nhóm dân nghèo đô thị không được chăm sóc y tế, vệ sinh cá nhân kém dễ mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch
- Tại nơi ở thiếu nước sạch, không khí sạch,thực phẩm sạch, chất thải không được xử lý
- Ở nơi nhà ở chật chội, mật độ dân cư đông đúc, thói quen không vệ sinh
- Tệ nạn xã hội: tiêm chích ma túy, mại dâm
- Thiếu dinh dưỡng: làm giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm
- Thiếu phương tiện, dịch vụ y tế : khả năng phòng và chữa bệnh truyền nhiễm giảm

2.2. Các bệnh không truyền nhiễm và chấn thương

- Các bệnh do ô nhiễm (bệnh nghề nghiệp)
- Các chấn thương tai nạn (trong lao động, giao thông, sinh hoạt)

- Các bệnh do lối sống (căng thẳng thần kinh, tâm thần, ít vận động, ăn nhiều, nghiện...)

*Phần đông các bệnh mạn tính và chấn thương đang là gánh nặng cho SK đô thị, do các nguyên nhân sau:

+ Do tác hại về mặt cấu trúc trong nhà ở, giao thông, nghề nghiệp, xây dựng không an toàn, thiếu thiết bị cần thiết

+ Do chọn nơi định cư bị ảnh hưởng bởi chất thải công nghiệp, sinh hoạt gây ô nhiễm đất, nước, không khí

+ Những tiếp xúc lớn hơn do chất độc, chất ăn da trong công nghiệp, gia đình

+ Do ô nhiễm không khí, bụi hơi khí độc, giao thông... gây ra

2.3. Các vấn đề về SK tâm thần

- Gia tăng sự cô đơn của cá nhân và gia đình
- Căng thẳng về mặt xã hội do khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, không có nơi ở.
- Căng thẳng ở đô thị gây trầm cảm, lo âu, tự tử, nghiện hút...
- Căng thẳng do quá đông, ồn ào, kỳ thị...
- Phân chia giàu nghèo, không đảm bảo an ninh, không có công việc ổn định.
- Người già đô thị dễ mắc các bệnh tâm thần hơn nông thôn, trẻ vị thành niên đô thị dễ mắc và gia tăng hành vi tội lỗi, phạm pháp, bạo lực

2.4. Các vấn đề SK đối với nhóm người đặc biệt:

- Trẻ em đô thị: Về phương diện sinh học và xã hội trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng, tai nạn, dễ bị bỏ rơi, tị nạn, ngộ độc, bóc lột, hành hạ, lang thang, không được giáo dục nhất là trẻ em nghèo, mất người thân, gia đình ly tán, cha mẹ lý dị.

- Tuổi vị thành niên và trước vị thành niên: dễ bị chấn thương, tử vong do tai nạn, sát nhân, bạo lực, tị nạn, chán đời, tự tử.

- SK của phụ nữ đô thị: nhất là phụ nữ nghèo: bị lao động nặng nhọc, không có chăm sóc y tế, thiếu kiến thức, thiếu điều kiện vệ sinh, dễ mắc tị nạn, thu nhập thấp.

- Người già đô thị: dễ bị cô đơn, bỏ rơi

- Người tàn tật đô thị: dễ bị khinh rẻ, bỏ rơi

- Người lao động tự do ở đô thị: dễ bị bóc lột, lao động trong MT ô nhiễm, không được hưởng các dịch vụ xã hội, dễ bị tai nạn nhiễm độc.

Câu 12. Nguyên nhân, yếu tố nguy cơ các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị học đường.

1.Cong vẹo cột sống

a. ĐN: Cong vẹo cột sống là bệnh lý biến dạng cột sống ở lứa tuổi học sinh chủ yếu do ngồi học sai tư thế.

b.Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây cong vẹo cột sống:

❖ Điều kiện học tập không đảm bảo vệ sinh, tạo ra tư thế xấu trong quá trình ngồi học

- Ngồi học trên những bộ bàn ghế không phù hợp với chiều cao của học sinh: bàn cao, ghế thấp hoặc bàn thấp ghế cao.

- Thiếu ánh sáng hoặc chiếu sáng ở phía tay phải của học sinh, do đó học sinh phải ngồi lệch người về một bên để đón lấy ánh sáng, từ đó tạo nên tư thế xấu.

- Khoảng cách bảng, bàn không phù hợp.

❖ Thói quen học tập không đúng:

- Tư thế khi ngồi học xấu, không hợp vệ sinh

- Xách/đeo cặp 1 bên

- Thời gian học quá lâu

❖ Những nguyên nhân không phải do trường học như:

- Học sinh phải lao động bằng chân tay sớm

- Di chứng một số bệnh: Lao cột sống

- Tình trạng dinh dưỡng: Còi xương

2.Cận thị học đường

a.ĐN: Cận thị học đường là tật khúc xạ khi đó con người chỉ có khả năng phân biệt các chi tiết nhỏ của các vật và hình ảnh nằm trong cự ly gần. Những vật đó khi nằm ở cự ly xa sẽ được ghi nhận lại một cách mờ không rõ nét.gặp ở lứa tuổi học sinh thường do thói quen và điều kiện học tập gây nên.

b.Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây bệnh cận thị học đường

- Thiếu ánh sáng trong quá trình học tập: Thiếu cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo ở trong phòng học do cấu trúc của phòng học không đúng quy cách, chiếu sáng nhân tạo thiếu do phòng học không có nguồn sáng hoặc treo các bóng đèn quá cao, công suất thấp số lượng bóng lại ít, dùng bóng đèn nê ông một pha...

- Do bàn và ghế học sinh không đủ tiêu chuẩn vệ sinh

- Do học sinh vi phạm các qui định vệ sinh trong học tập: Tư thế ngồi học không đúng.Thói quen đọc sách không đúng: cúi nhiều, nhìn gần hoặc đọc sách quá lâu ở nơi thiếu ánh sáng (đọc sách ở trong màn...).

- Chất lượng học phẩm không đảm bảo:

- +Chất lượng học phẩm kém không phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh, chữ in trong các sách giáo khoa quá bé, làm cho mắt phải làm việc nhiều, chóng mỏi mệt.

- +Nơi học tại gia đình không có bàn ghế học tập hoặc nơi học không đảm bảo ánh sáng, phương tiện học tập, bàn ghế không phù hợp.

- +Bảng bóng, phấn mờ, sách học, sách chuyện chữ nhỏ mờ, chất lượng giấy xấu

- Xem tivi, chơi điện tử, sử dụng máy vi tính quá nhiều

Câu 13. Ảnh hưởng SK và biện pháp dự phòng các bệnh cong vẹo cột sống và cận thị học đường.

1. Bệnh cận thị học đường

a. Tác hại

- Đối với kết quả học tập: ảnh hưởng chất lượng và kết quả học tập vì không nhìn rõ chữ và hình vẽ trên bảng (nếu không đeo kính)
- Trong sinh hoạt và nghề nghiệp: mọi sinh hoạt, đi lại, chậm chạp khó khăn, dễ mắc tai nạn giao thông nghề nghiệp, khó lựa chọn một số ngành, nghề.
- Đối với SK: bệnh tăng lên nếu không kịp thời đeo kính, biến chứng nguy hiểm nhất: bong võng mạc => mù

b. Biện pháp dự phòng

- Lớp học, góc học tập được chiếu sáng tốt
- Bàn và ghế học sinh phải có kích thước phù hợp với chiều cao của học sinh
- Thực hiện nếp sống vệ sinh trong học tập
- Ăn thực phẩm có nhiều Vitamin A, đặc biệt các kì ôn tập thi cuối kỳ, cuối năm, cuối cấp học
- Học sinh cần được khám SK định kỳ để phát hiện sớm bệnh
- Đảm bảo chất lượng học phẩm
- Học sinh không xem tivi, chơi điện tử, sử dụng máy vi tính quá nhiều

2. Bệnh cong vẹo cột sống

a. Tác hại :

Tùy theo mức độ biến dạng cột sống mà ảnh hưởng đến SK học sinh:

- Mức độ I: Chưa có ảnh hưởng gì
- Mức độ II: Ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể. Tư thế xấu như gù, ưỡn, vai bị lệch sang 1 bên hoặc bên cao bên thấp; chức năng hô hấp giảm
- Mức độ III: Ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng hô hấp → khả năng lao động không cao và không kéo dài

Nếu ở nữ sẽ có ảnh hưởng sự sinh sản do khung chậu lệch

b. Dự phòng biến dạng cột sống

- Bàn ghế học sinh phải đúng tiêu chuẩn vệ sinh
- Lớp học được chiếu sáng tốt, đúng tiêu chuẩn vệ sinh
- Học sinh cần được hướng dẫn tư thế ngồi học đúng trong quá trình học tập ở lớp, ở nhà
- Phụ huynh, học sinh và nhà trường cần bố trí thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý cho học sinh
- Không lao động nặng (gồng gánh) sớm
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh, tiêm phòng đầy đủ.

Câu 14. Các biện pháp xử lý chất thải của người.

(Tùy vào câu hỏi đề ra tổ hợp những ý nào mà SV chọn làm bài)

	Nhà tiêu tự hoại	Nhà xí thấm dội	Nhà xí hai ngăn, ủ phân tại chỗ	Nhà tiêu đào có ống thông hơi
Nguy hại tác động	- Ngăn chặn mùi hôi bằng nút nước - Phân được phân hủy kỵ khí toàn bộ - Nước thải được xả vào hệ thống cống rãnh	- Ngăn chặn mùi hôi bằng nút nước - Phân được phân hủy kỵ khí một phần - Nước thải được thấm ra đất xung quanh	- Chỉ xây dựng ở vùng nông thôn có sử dụng phân đã ủ để làm phân bón - Hoạt động trên cơ sở các vi sinh vật hoại sinh, phải có hai ngăn riêng biệt, một ngăn để phóng uế, một ngăn để ủ, dùng luân phiên. - Dùng tro và chất độn để cách ly phân	- Dùng tro và chất độn để cách ly phân - Phân hoàn toàn không được xử lý - Phải đào nhà tiêu mới sau khi đã sử dụng nhà tiêu cũ
Ưu điểm	- Không có mùi hôi - Ít tốn diện tích đất, có thể đặt trong nhà - Có thể dùng nơi công cộng	- Không gây ô nhiễm không khí và không có mùi hôi - Tốn ít nước - Dễ sử dụng , bảo quản - Có thể xây dựng ngay trong nhà	- Không cần sử dụng nước - Sử dụng cho sản xuất nông nghiệp - Không cần hệ thống cống rãnh	- Ít tốn kém - Không cần sử dụng nước - Không cần hệ thống cống rãnh
Nhược điểm	- Giá thành cao - Phân không được dùng cho mục đích nông nghiệp - Tốn nhiều nước	- Giá thành xây dựng cao, nhất là ở nông thôn - Kỹ thuật đặt xiphông phải tốt - Có thể gây ô nhiễm mạch nước ngầm, cần nghiên cứu thêm về khả năng thấm của đất(kể cả thấm ngang và thấm đứng để ấn định khoảng cách vệ sinh) trước khi xây dựng.	- Giá thành khá cao - Có mùi hôi - Tốn diện tích, không đặt trong nhà được - Không dùng nơi công cộng	- Không sử dụng được nơi đất chật người đông, vùng ngập nước - Vẫn còn có mùi khó chịu - Khi hố tiêu đầy phải đổi đi chỗ khác hoặc lấy phân ra - Có thể làm ô nhiễm nguồn nước

	Nhà tiêu tự hoại	Nhà xí thẩm dội	Nhà xí hai ngăn, ủ phân tại chỗ	Nhà tiêu đào có ống thông hơi
Sử dụng và bảo quản	-Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước không có bọt gây -Không có mùi hôi thối -Nước từ bể xử lý chảy vào cống hoặc hố thấm, không chảy tự do ra xung quanh -Nhà tiêu sạch, không có rêu trơn, giấy, rác -Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bản có nắp đậy -Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu -Bệ xí sạch, không dính, đọng phân -Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa	-Có đủ nước dội, dụng cụ chứa nước không có bọt gây -Không có mùi hôi thối -Nhà tiêu sạch, không có rêu trơn, giấy, rác -Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bản có nắp đậy -Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu -Bệ xí sạch, không dính, đọng phân Nhà tiêu được che chắn kín, ngăn được nước mưa	-Sàn nhà tiêu cần sạch, không có giấy, rác -Không để có mùi hôi thối -Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bản có nắp đậy -Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu -Không sử dụng đồng thời 2 ngăn -Có đủ chất độn và bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau mỗi lần đi tiêu -Không có bọt gây trong dụng cụ chứa nước (nếu có) và dụng cụ chứa nước tiêu -Không lấy phân trong ngăn ủ ra trước sáu tháng -Lỗ tiêu ngăn đang sử dụng phải luôn được đậy kín, ngăn ủ được trát kín.	-Sàn nhà tiêu sạch, không có giấy, rác -Không có mùi hôi thối -Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu -Không có ruồi hoặc côn trùng trong nhà tiêu -Có đủ chất độn và bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau mỗi lần đi tiêu -Không có bọt gây trong dụng cụ chứa nước (nếu có) và dụng cụ chứa nước tiêu -Không lấy phân trong ngăn ủ ra trước sáu tháng -Lỗ tiêu thường xuyên được đậy kín.

Câu 15. Nhiễm trùng bệnh viện và các biện pháp dự phòng.

❖ **Khái niệm NTB:** NTB là NT mắc phải khi bệnh nhân nằm viện mà lý do nhập viện không phải do nhiễm trùng đó. Nhiễm trùng này xảy ra trong thời hạn 48 giờ sau khi nhập viện và trong thời hạn 30 ngày đối với nhiễm trùng vết mổ. NTB liên quan tới thực hành chăm sóc, điều trị, và là hậu quả không mong muốn của quá trình thực hành y học trong bệnh viện. NTB là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng bệnh viện.

❖ Những biện pháp phòng chống các NTB (2 cấp độ)

a..Dự phòng chuẩn cho mọi bệnh nhân

- Chỉ định:
 - Không biết tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân tại thời điểm nhập viện
 - Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ cả ở những BN biết và không biết là nguồn NK
 - Được thực hiện trong tất cả các cơ sở y tế
 - Các biện pháp dự phòng chuẩn cho mọi bệnh nhân:
 - Vệ sinh bàn tay đúng (2 trước, 3 sau)
 - Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
 - Bảo đảm thu gom chất thải thích hợp (hộp đựng vật sắc nhọn, kim tiêm)
 - Lau, loại bỏ ngay dịch/máu bị tràn
 - Đảm bảo dụng cụ chăm sóc BN được loại bỏ, khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn giữa mỗi BN
- b.Phòng ngừa bổ sung** dựa vào đường lây với BN nghi ngờ/ mắc nhiễm khuẩn.

- Dự phòng tiếp xúc:

Chỉ định: Có tiếp xúc với các bệnh dễ lây trong bệnh viện như Tiêu chảy, nhiễm khuẩn tiêu hoá, tổn thương da

Các biện pháp dự phòng tiếp xúc:

- Buồng riêng cho mỗi bệnh nhân (nếu thích hợp)
- Đi găng khi vào phòng, mặc áo choàng khi tiếp xúc với BN, bề mặt, vật liệu bị NK.
- Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, và khi rời buồng bệnh.
- Hạn chế bệnh nhân ra ngoài buồng bệnh
- Làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ và MT thích hợp

- Dự phòng qua các giọt nhỏ

Chỉ định: Đối với các giọt nhỏ có kt >5µm phòng các bệnh: viêm màng não, bạch hầu...

Các biện pháp dự phòng qua các giọt nhỏ

- Bố trí buồng riêng cho mỗi bệnh nhân (nếu có thể)
- Khẩu trang cho nhân viên y tế
- Hạn chế di chuyển bệnh nhân, bệnh nhân đeo khẩu trang ngoại khoa khi rời buồng bệnh

- Dự phòng qua đường không khí

Chỉ định: Đối với các mầm bệnh có kích thước < 5µm phòng các bệnh: lao, sởi, thủy đậu

Các biện pháp dự phòng qua đường không khí

- Bố trí buồng riêng có thông khí thích hợp (áp lực âm nếu có thể),
- Sử dụng khẩu trang có độ lọc cao khi ở trong buồng bệnh (ví dụ loại N95)
- Bệnh nhân luôn ở trong buồng bệnh

Như vậy, Phòng ngừa chuẩn là là biện pháp phòng ngừa cơ bản phòng nhiễm khuẩn .Phòng ngừa bổ sung là biện pháp quan trọng giúp kiểm soát đường lây truyền NK.

Câu 16. Tác hại của các chất gây ô nhiễm nhà ở với SK.

1. Các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm nhà ở:

- Các bệnh nhiễm trùng, kst, các bệnh lây qua đường hô hấp
- Các vấn đề sk do bụi, hơi khí độc: tổn thương đường hô hấp trên, dưới, TMH, viêm da niêm mạc, dị ứng, bệnh nghề nghiệp, nhiễm độc
- Hội chứng đau yếu trong nhà (SBS): mệt mỏi, buồn ngủ, nhức đầu, cay mắt, mắt tập trung, kích thích mũi họng, hoa mắt, chóng mặt, đau cổ, đau lưng, tức ngực, sốt...

2. Ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm trong nhà đối với SK:

*** Radon:**

- + Gây K phổi
- + Khả năng mắc bệnh phụ thuộc vào nồng độ Rn.
- + Nguy cơ cao: người hút thuốc lá, trẻ em, người sống ở tầng trệt

*** Ảnh hưởng của Amiăng:**

- Gây bệnh Asbestosis
- Ung thư trung biểu mô
- Ung thư phổi. Nghiện thuốc lá càng dễ bị ung thư
- Có thể gây ung thư tại thực quản, khí quản, vòm họng, dạ dày, ruột, thận.

*** Ảnh hưởng của Formaldehyt:**

- Phụ thuộc vào sự nhạy cảm của từng người
- Gây kích thích mắt, mũi, họng; mức độ tỷ lệ với nồng độ.
- Nặng hơn: khó thở, nhức đầu, mệt mỏi, giảm chức năng phổi.
- Gây K: xuất hiện ung thư hệ tiêu hóa, dạ dày, ruột non, tuyến tụy, bàng quang, thận, da....

*** Ảnh hưởng của VOCs:**

- Suy giảm hoạt động hệ TKTW: uể oải, mệt mỏi, khó chịu
- Khả năng gây ung thư: nguy cơ do VOCs là 0,2-0,3.

*** Ảnh hưởng của thuốc diệt côn trùng:**

- Tất cả các thuốc diệt trùng đều độc.
- Gây kích thích da, mắt, hệ hô hấp, ảnh hưởng sự dẫn truyền của hệ TK.
- Nhiều chất có khả năng gây ung thư, đẻ non, gây đột biến di truyền

*** Tác hại của các chất khí là sản phẩm quá trình đốt cháy:**

- CO: $CO + Hb = COHb$ (nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ngất và tử vong)
- NO₂: giảm chức năng phổi, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
- SO₂: hấp thu ở màng nhầy hệ hô hấp, tạo thành H₂SO₃, H₂SO₄ gây co thắt khí quản, nguy cơ cao cho người bị bệnh hen. Nguy hiểm hơn khi kết hợp với hạt aerosol và độ ẩm cao.

- CO₂: là chất chỉ thị MT trong nhà có tích tụ chất ô nhiễm ? Nồng độ >1000ppm
-> khó thở.

- Khói thuốc lá: Ung thư phổi, tim mạch tiềm tàng, hô hấp.

***Ảnh hưởng của tác nhân sinh học:**

- Nhóm bệnh tai-mũi-họng: viêm mũi, viêm xoang, viêm tai

- Nhóm bệnh phổi-phế quản: viêm phổi, hen, bệnh nấm phổi-phế quản, viêm phế nang.

- Viêm kết mạc

- Nhóm bệnh da liễu: viêm da tiếp xúc, eczema mẫn cảm, mày đay tiếp xúc.

- Một số bệnh khác: dị ứng, sốt do máy làm ẩm, hội chứng SBS.

***Tác hại của chì:**

- Gây tác hại cho não, hệ TKTW, thận, hồng cầu.

- Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với chì, làm chậm phát triển trí tuệ và thể lực

***Hội chứng đau yếu trong nhà(SBS):**

- **Khái niệm :** là để chỉ những tòa nhà mà người sống ở đó bị ảnh hưởng đến SK nhưng không có một nguyên nhân đặc hiệu nào

-**Triệu chứng:** Thể hiện các triệu chứng ở mắt, đầu, mũi họng, ngực, da và mệt mỏi. Có vấn đề về hội chứng nhà kín khi trên 20% số người sống trong nhà đó than phiền về chất lượng không khí gây hại cho

SK, nhất là những người có cơ địa dị ứng, lao động quá sức, hoặc chịu nhiều stress

-Các dấu hiệu cụ thể:

Mắt: bị cay, ngứa. chảy nước, sưng nặng mí mắt; Mũi: bị cay (Kích thích), chảy nước mũi, tắc mũi,

chảy máu cam; Họng: bị ngứa, khô, đau; Da: bị khô, ngứa ở mặt, ở tay, ban đỏ;

Toàn thân: Nhức đầu, buồn nôn, chán ăn, chóng mặt, mệt hoặc quá mệt mỏi, hồi hộp (bồn chồn), khó tập trung (chú ý kém, khó nhớ), mất ngủ, khó cử động hay đau ở cổ, ở lưng, ngực.

-**Nguyên nhân:** Sự ô nhiễm không khí nhà ở chủ yếu: đun nấu, do thiết kế phòng, vật liệu xây dựng, đồ đạc nội thất, không khí lưu thông....

Ô nhiễm từ bên ngoài: Bụi khí, độc thâm nhập vào nhà

Ô nhiễm bên trong: Chính, gồm:

+ Chất hóa học: chủ yếu, xuất phát từ TTB, đốt nhiên liệu trong nhà: CO₂, CO, Cl₂, Formaldehyt, benzen, etylen.

+ Yếu tố sinh học: Phân hoa, vi khuẩn, virus, nấm mốc, KST

+ Các yếu tố lý học như: Nhiệt độ cao, tiếng ồn...

Câu 17. Các bệnh tật liên quan đến lối sống: (Chỉ học phần béo phì)

Lối sống là những nét điển hình, được lặp đi lặp lại và định hình thành phong cách thói quen trong đời sống cá nhân, nhóm xã hội, dân tộc hay là cả một nền văn hóa.

Các lối sống liên quan đến SK: hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ma túy, tình dục không an toàn, chế độ ăn.

Bệnh lối sống (bệnh không lây nhiễm) là bệnh có liên quan với các cá nhân sống hằng ngày. Một số lối sống gây ra các vấn đề SK phổ biến là chế độ ăn không hợp lý, thiếu vận động thể lực, lạm dụng rượu bia và hút thuốc lá.

• Vấn đề SK liên quan tới chế độ ăn không hợp lý: bệnh béo phì

***Do chế độ ăn không hợp lý:**

- Thừa Protein động vật, chất béo no
- Thiếu rau xanh, hoa quả, chất xơ
- Năng lượng nên lấy 15% từ động vật, 85% từ các loại rau xanh, hoa quả, hạt.

***Tình trạng béo phì trên thế giới:**

Năm 2015 tỷ lệ béo phì gấp đôi năm 1980. Năm 2014, 1,9 tỷ người trên 18 tuổi bị thừa cân. Năm 2013, 42 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân béo phì. Béo phì là bệnh có thể dự phòng được

***Tại Việt Nam:** điều tra năm 2009-10: Thừa cân, béo phì trẻ <5 tuổi 2,8%, thừa cân, béo phì trưởng thành 5,6%. Nam: 55-59: 7,8%, nữ: 50-55: 10,9%

***Theo phân loại của WHO theo BMI:**

- Bình thường: BMI 18.5- 24.9
- Thừa cân: BMI 25- 29.9
- Béo phì : BMI ≥ 30

***Nguy cơ SK do béo phì:**

- Tăng nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm như:
 - + Bệnh tim mạch (chủ yếu là bệnh tim và đột quỵ)
 - + Đái tháo đường
 - + Rối loạn CXXK (thoái hóa khớp là nguyên nhân gây bệnh khớp hàng đầu)
 - + Ung thư (vú, đại tràng, nội mạc tử cung)
 - + Nguy cơ mắc bệnh tỉ lệ thuận với chỉ số BMI
 - + Trẻ em béo phì có nguy cơ bị bệnh sớm (cao huyết áp, bệnh tim mạch, đề kháng Insulin) và tàn tật khi trưởng thành.

***Dự phòng béo phì:**

Cá nhân:

- Hạn chế lấy năng lượng từ chất béo và đường
- Tăng sử dụng rau xanh, hoa quả cũng như đậu, các loại hạt lạc, vừng.
- Tăng vận động thể lực (60 phút 1 ngày đối với trẻ nhỏ, 150 phút 1 tuần đối với người trưởng thành)

Xã hội:

- Tổ chức xã hội, các bên có liên quan hỗ trợ thông qua các chính sách, chương trình.
- Giúp cho cộng đồng tiếp cận với chế luyện tập và chế độ ăn lành mạnh dễ dàng, đặc biệt là với người nghèo.

Công nghiệp thực phẩm:

- Giảm chất béo, đường, muối trong quá trình chế biến.
- Đảm bảo khả năng chi trả cho thức ăn lành mạnh
- Đặc biệt là thức ăn cho trẻ em và vị thành niên
- Đảm bảo ở nơi làm việc có hoạt động thể lực, thức ăn lành mạnh cho nhân viên

Câu 18. Nội dung, yêu cầu đánh giá tác động MT.

Đánh giá tác động MT (ĐTM) là việc xem xét ảnh hưởng qua lại giữa MT với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.

1. Nội dung ĐTM:

Nội dung của một công tác ĐTM cụ thể tùy thuộc vào: nội dung và tính chất của hoạt động phát triển, tính chất và thành phần của MT chịu tác động của hoạt động phát triển, yêu cầu và khả năng thực hiện việc đánh giá. ĐTM-văn bản chính thức mô tả quá trình ĐTM và trình bày kết quả ĐTM-thường gồm có:

- Mô tả địa bàn nơi sẽ tiến hành hoạt động phát triển, đặc trưng kinh tế kỹ thuật của hoạt động phát triển.
- Xác định phạm vi đánh giá của nội dung ĐTM
- Mô tả hiện trạng MT tại địa bàn được đánh giá
- Dự báo những thay đổi về MT có thể xảy ra trong và sau khi thực hiện hoạt động phát triển.
- Dự báo về những tác động có thể xảy ra đối với tài nguyên và MT, các khả năng hoàn nguyên hiện trạng hoặc tình trạng không thể hoàn nguyên.
- Các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh.
- Phân tích lợi ích và chi phí mở rộng.
- So sánh các phương án hoạt động khác nhau.
- Kết luận và kiến nghị.

2. Quá trình thực hiện ĐTM

Căn cứ vào nội dung trên, **quá trình thực hiện ĐTM** thường gồm các bước sau:

- (1)Tiến hành các công tác chuẩn bị cho đánh giá như tổ chức, kinh phí, phương tiện làm việc, tư liệu, số liệu.
- (2)Quyết định về phạm vi đánh giá với sự nhất trí với các bên liên quan và theo quyết định chính thức của cơ quan có trách nhiệm.
- (3)Nắm tình hình khái quát về hoạt động phát triển và hiện trạng MT.
- (4)Xác định, phân tích và dự báo các tác động.
- (5)Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh.

3. Các yêu cầu đối với ĐTM

Với nội dung, ý nghĩa như trên, công tác ĐTM nói chung và báo cáo ĐTM nói riêng cần đạt được những yêu cầu sau :

- Phải thực sự là một công cụ giúp cho việc lựa chọn quyết định. Thực chất của ĐTM là cung cấp thêm tư liệu đã được cân nhắc, phân tích một cách khoa học về những lợi ích và tổn thất có thể về tài nguyên MT, để cơ quan có trách nhiệm ra quyết định có điều kiện lựa chọn phương án hành động phát triển một cách hợp lý, chính xác hơn
- Phải đề xuất được phương án phòng tránh, giảm bớt các tác động tiêu cực, tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu phát triển.
- Phải là công cụ có hiệu lực để khắc phục những hậu quả tiêu cực của các hoạt động đã được hoàn thành hoặc đang tiến hành. Hiện tại, nhiều hoạt động đang có những tác động tiêu cực về tài nguyên MT. Đối với những hoạt động như vậy cần thực hiện ĐTM, trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế các tác động tiêu cực đó
- ĐTM phải là một hoạt động khoa học mang tính liên ngành. Phải huy động nhiều cán bộ khoa học và thực tiễn thuộc các ngành có liên quan tham gia công tác ĐTM.
- Báo cáo ĐTM phải rõ ràng, dễ hiểu. báo cáo ĐTM phải thật sự rõ ràng, dùng ngôn ngữ, thuật ngữ phổ thông, dễ hiểu. Cách diễn đạt và trình bày phải cụ thể, có sức thuyết phục, giúp người quyết định nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng, khách quan, từ đó có quyết định đúng đắn, kịp thời
- Báo cáo ĐTM phải chặt chẽ về mặt pháp lý. Báo cáo ĐTM không những là cơ sở khoa học mà còn là cơ sở pháp lý giúp cho việc quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến đời sống và quyền lợi vật chất, tinh thần của nhân dân trong một quốc gia hoặc một địa phương
- Hợp lý trong chi tiêu cho ĐTM.
- Đặc biệt cần chú ý tránh việc tiến hành ĐTM lúc đã có thể xác định rằng hoạt động phát triển không có tác động tiêu cực đáng kể đối với MT

“Câu 19, câu 20, sinh viên chú ý đọc kỹ câu hỏi để chọn lọc ý phần đã giới hạn để làm bài. Chưa biết rõ câu hỏi cụ thể”

Câu 19: Định nghĩa thảm họa MT, phân loại và 10 nhiệm vụ cấp bách của y tế tuyến tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt:

1.Khái niệm thảm họa:

*Định nghĩa thảm họa: Là những hiện tượng, biến cố bất ngờ gây tổn thất lớn về người và của vượt quá khả năng tự bù đắp của địa phương nơi xảy ra thảm họa.

* Về y tế, các thảm họa thường gây ảnh hưởng lớn đến con người như tổn thất về sinh mạng, bị thương, bị bệnh, ảnh hưởng xấu đến SK, đòi hỏi sự đáp ứng y tế khẩn cấp.

*Một thiên tai hoặc thảm họa nhất thiết phải hội đủ một số tiêu chuẩn sau:

- Ít nhất có 10 người chết trở lên hoặc ít nhất có trên 100 người bị ảnh hưởng
- MT bị tàn phá hoặc bị ô nhiễm nặng nề
- Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia
- Kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế

*Bộ Y tế quy định mức độ thảm họa (theo số nạn nhân):

- + Mức 1: 30-100 nạn nhân /20-50 nhập viện.
- + Mức 2: 101-500 nạn nhân /51-200 nhập viện
- + Mức 3: 501-2000 nạn nhân /201-300 nhập viện.
- + Mức 4: trên 2000 nạn nhân /trên 300 nhập viện

2.Phân loại thảm họa:

***Do thiên nhiên:** do những biến đổi bất thường về khí tượng, về địa lý và sinh thái: bão, lụt, động đất, núi lửa, sóng thần, nóng bức, lạnh, hạn hán, lở đất....

***Thảm họa do con người gây ra bao gồm:**

- Các tai nạn công nghiệp.
- Các tai nạn giao thông.
- Các tai nạn xây dựng - kiến trúc.
- Thảm họa do phá hoại MT, gây ô nhiễm nặng MT sống
- Thảm họa do bệnh dịch (các dịch bệnh tối nguy hiểm, các đại dịch).
- Thảm họa do các yếu tố xã hội - chính trị - kinh tế.

3. 10 nhiệm vụ cấp bách của y tế tuyến tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt:

1. Hướng dẫn, vận động người dân ăn chín, uống sôi, dùng viên cloramin khử trùng nước trước khi dùng. Hướng dẫn cách pha hóa chất khử trùng, làm sạch MT, xử lý nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
2. Nước rút đến đâu hướng dẫn làm sạch vệ sinh MT, thu gom, chôn rác, xác động vật.
3. Giám sát, quản lý các kho thuốc trừ sâu nếu có mất mát, phân tán ra xung quanh phải khoanh vùng xử lý.
4. Tăng cường quản lý chất lượng VSATTP, cấm việc bán thịt gia súc, gia cầm chết, giết mổ không hợp vệ sinh.
5. Kịp thời phát hiện và dập tắt dịch tiêu chảy, đau mắt đỏ, nước ăn chân, đề phòng dịch tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, sốt rét...
6. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi ở vùng trọng điểm để phòng sốt xuất huyết, sốt rét
7. Triển khai sử dụng các loại vắc xin phòng bệnh khi có chỉ định.
8. Khôi phục các cơ sở y tế: sửa chữa các nhà, trạm hỏng, nhanh chóng khôi phục hoạt động của cơ sở y tế.
9. Khôi phục các máy móc, thiết bị ở các cơ sở y tế.
10. Củng cố tủ thuốc thiết yếu, nhất là những nơi bị trôi, hư hỏng, ngập ướt, cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho dân.

Câu 20: Các biện pháp dự phòng trong và sau thảm họa:

1.Xử lý nước ăn uống và vệ sinh MT trong và sau khi ngập lụt:

a. Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt sau ngập lụt:

*** Giếng khơi**

Quy trình xử lý nước được tiến hành theo 3 bước sau:

- Bước 1: Thau rửa giếng
- Bước 2: Làm trong nước giếng
- Bước 3: Khử trùng nước giếng

Cụ thể:

Bước 1: Thau rửa giếng

- Khơi thông tất cả các vùng nước xung quanh khu vực giếng.
- Tháo bỏ nắp ni long bịt giếng
- Thau vét giếng, dùng nước giếng dội lên thành, sân giếng.

Bước 2: Làm trong nước giếng

- Dùng phèn chua liều lượng là 50g/1 m³ nước, nếu nước đục nhiều có thể cho lượng phèn tối đa là 100g/1m³ nước.
- Hoà tan hết lượng phèn cần thiết vào một gầu nước, tưới đều lên giếng nước, thả gầu chìm sâu xuống nước rồi kéo mạnh lên khoảng 10 lần, để từ 30 phút đến 1 giờ cho cặn lắng xuống hết.

Bước 3: Khử trùng giếng nước:

- Nguyên tắc nước giếng sau khi khử trùng phải có nồng độ Chlor thừa là 0,5-1,0mg/lít (có mùi nồng của Chlor).
- Có thể dùng một số hoá chất khác như: Chlorua vôi 20% (13g/m³) hoặc Chlorua vôi 70% (4g/m³).
- Múc một gầu nước, hòa lượng hóa chất trên vào, khuấy cho tan hết. Tưới đều gầu này vào giếng. Thả gầu cho chìm sâu đến nửa cột nước, kéo lên xuống khoảng 10 lần. Nếu không thấy mùi chlor, cho thêm hóa chất dần đến khi có mùi chlor.
- Dùng nước này dội thành giếng để khử trùng, để khoảng 30 phút mới dùng.
- Đun sôi mới được uống.

***Giếng khoan:**

- Bơm hết nước đục, bơm tiếp 15 phút, bỏ nước đi, sau bước này có thể sử dụng
- Cần chú ý làm vệ sinh bơm, sàn giếng

b.Xử lý vệ sinh MT:

- Nước rút đến đâu các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó đẩy phù sa từ nhà, sân, đường đi.

- Khi nước rút hết, MT ô nhiễm nặng nề do xác súc vật, côn trùng, cây cối thối rữa. Cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết, và tẩy uế
- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không treo mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ để làm nơi trú ẩn cho muỗi.
- Làm vệ sinh và tu sửa nhà tiêu (nếu không hỏng nặng). Nếu hỏng nặng, chọn nơi cao ráo xa nhà, xa giếng ($\geq 20\text{m}$) đào hố tạm trong khi chờ xây mới (chú ý lấp đất, tránh ruồi, côn trùng và súc vật).
- Tiến hành sớm các biện pháp diệt côn trùng và trung gian truyền bệnh.

2. Dịch bệnh sau thảm họa:

Do tác nhân trong nước: Tiêu chảy, Tả, Lỵ trực trùng....

Do vector trong nước: sốt rét, sốt xuất huyết, VNNB

Do tiếp xúc: đau mắt đỏ, viêm da, viêm đường hô hấp cấp...

2.1. Các dịch bệnh do tác nhân trong nước và do tiếp xúc:

+ Các bệnh tiêu chảy do nhiễm khuẩn (E.coli, Shigella, Salmonella...), do ký sinh trùng

(Entamoeba histolytica...), do vi rút (Rotavirus, Enterovirus...), do nấm (Candida Albicans).

+ Đau mắt đỏ.

+ Bệnh ngoài da.

+ Các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp.

a. Các bệnh tiêu chảy:

*** Thường gặp sau thảm họa do:**

- Cơ sở hạ tầng bị tàn phá diện rộng
- Chất lượng nước không đảm bảo
- Điều kiện vệ sinh thấp kém
- Di chuyển nhiều người dân vào nơi ở sống tạm thời
- Nhiều nguồn gây ô nhiễm thực phẩm và ô nhiễm nước

*** Phòng bệnh tiêu chảy, tả, lỵ...**

- Thực hiện đúng nguyên tắc ăn chín uống sôi.
- Không nên ăn rau sống, nếu ăn thì phải khử trùng bằng nước có pha chất khử trùng
- Uống hoặc tiêm các vaccin phòng bệnh khi có chỉ định.
- Cung cấp nước và thực phẩm đảm bảo
- Xử lý chất thải sau thảm họa

b. Phòng bệnh đau mắt đỏ:

- Viêm kết mạc cấp do vi khuẩn, vi rút do dùng nước bẩn.

- Không lau rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn
- Không để trẻ em tắm gội, chơi đùa với nước bẩn.
- Rửa tay với nước sạch
- Không dùng chung khăn mặt, chậu rửa với người đang bị đau mắt đỏ.
- Chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành.

c. Phòng bệnh ngoài da do nước bẩn:

- Không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn.
- Nếu không có nước giếng đã khử trùng thì phải đánh phèn hoặc lọc cát cho trong nước để tắm giặt.
- Không mặc quần áo ẩm ướt.
- Không để trẻ em bơi lội, tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập lụt.
- Hạn chế lội vào chỗ nước bẩn tù đọng. Nếu phải lội, phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón chân, ngón tay.

d. Nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp:

*Tăng nguy cơ viêm phổi do:

- Đông người
- Dễ nhạy cảm
- Suy dinh dưỡng
- Nơi ở tạm thời, điều kiện vệ sinh kém
- * Nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp trên
- * Nhiễm trùng đường hô hấp dưới (viêm tiểu phế quản, viêm phổi): phải nhập viện

(riêng ý d này không có cách phòng, sinh viên tự nghĩ viết thêm)

2.2. Các bệnh lây truyền qua nước(do các vector trong nước): Sốt rét và sốt xuất huyết:

- Nguy cơ thường cao sau thảm họa (lũ lụt sóng thần)
- Do tăng số lượng, loại vật chủ trung gian sống trong nước
- Muỗi sinh sản trở lại ngay sau khi nước bắt đầu rút.
- Dịch có thể xảy ra 4-8 tuần sau thảm họa

***Phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết:**

- Ngủ phải nằm màn
- Loại bỏ những vũng nước tù đọng là nơi sinh sản của muỗi.
- Phun hoá chất diệt côn trùng ở những nơi có nguy cơ cao hoặc khu vực có ổ dịch sốt rét, sốt xuất huyết.
- Thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia